

07 - 08- Les accidents d'exposition au sang AES - Pr. TASSI

Bonjour, aujourd'hui on va traiter les accidents d'exposition au sang. La définition d'un accident d'exposition au sang est toute exposition percutanée au contact d'une miqueuse, de l'œil ou de la bouche ou une peau lésée avec du sang ou un liquide biologique souillé avec du sang. La conduite à tenir en cas d'accident d'exposition au sang, il faut entretenir les premiers soins en urgence dans les premières 5 minutes qui suivent cet accident d'exposition au sang.

Consulter en urgence un médecin référent dans la prise en charge des accidents d'exposition au sang dans les premières 4 heures qui suivent cet accident d'exposition au sang. Une évaluation du risque sera faite en fonction du statut du patient source par rapport à l'infection à VIH, par rapport à l'hépatite B et à l'hépatite C. Une prophylaxie éventuelle peut être indiquée. Déclarer l'accident de travail dans les premières 24 heures qui suivent cet accident d'exposition au sang et contacter la médecine du travail en respectant le délai.

Une mise en place du suivi sera faite avec une analyse des causes de l'accident d'exposition au sang. En cas d'accident d'exposition au sang, il faut en premier interrompre le soin en cours. Confier le soin en cours à un collègue et ne pas oublier de calmer le malade s'il est agité pour ne pas être source d'un autre accident d'exposition au sang.

Deuxièmement, il faut entreprendre les premiers soins d'urgence dans les premières 5 minutes suivant l'accident d'exposition au sang. Ne jamais presser la plaie ou la faire saigner. Les premiers soins d'urgence sont Premièrement, nettoyage de la plaie à l'eau courante et au savon.

Deuxièmement, tremper la partie blessée dans l'un des produits suivants pendant 5 à 7 minutes, soit le daquin, le javel à 12 degrés dilué au indizien, l'alcool à 70 degrés ou le polyvidone iodé. Troisièmement, rincer avec de l'eau. En cas de projection sur le visage ou sur les yeux, il faut rincer abondamment à l'eau courante ou au sérum physiologique pendant 5 minutes au moins.

Ensuite, il faut contacter rapidement un médecin référent dans les premières 4 heures suivant l'accident d'exposition au sang. Un médecin référent doit être désigné dans tout établissement de soins. C'est un médecin qui est formé à la prise en charge des accidents d'exposition au sang.

Le nom du médecin référent et ses coordonnées doivent être communiqués à l'ensemble du personnel soignant de l'établissement. L'évaluation du risque sera faite en fonction du type de l'accident, de la profondeur de la blessure, de l'objet responsable de l'accident d'exposition au sang. Le risque augmente en cas d'aiguille creuse.

Il faut prendre en considération aussi le diamètre de l'aiguille. Ce risque augmente aussi en cas de gestes intravasculaires, intraveineux ou intraartériels. L'évaluation du risque prendra en considération aussi le délai entre le geste et l'accident d'exposition au sang et le temps de contact si projection.

L'évaluation du risque sera faite aussi en fonction du statut du patient source par rapport à l'infection à VIH, par rapport à l'hépatite B et à l'hépatite C. Il faut prendre en considération la charge virale, la positivité de l'ARN-VHC en cas d'hépatite active. Il faut prendre en considération aussi les traitements que prend le patient et vérifier s'il n'y a pas de notion de résistance au traitement. Le risque est important quand la piqûre est profonde, si aiguille creuse et intravasculaire, artérielle ou veineuse.

Le risque est intermédiaire dans les cas suivants. Coupure avec histoire, piqûre avec aiguille intravasculaire ou sous-cutanée, piqûre avec aiguille pleine, exposition cutanéo-muqueuse avec temps de contact supérieur à 15 minutes. Le risque est estimé minime en cas de piqûre avec des seringues abandonnées, en cas de contact avec des crachats, en cas de morsure ou griffure et dans les autres cas.

Après tout accident d'exposition au sang, il faut instaurer un suivi médical. Il faut évaluer le statut du patient source par rapport à l'infection à VIH, à l'hépatite C et à l'hépatite B. Pour cela, il faut demander un prélèvement initial qui comprend la recherche d'anticorps anti-VIH, la recherche d'anticorps anti-VHC, le dosage des transaminases et la recherche d'antigènes HPS. En fonction du résultat de ce bilan, soit que le patient source ne présente pas d'infection à VIH, ni hépatite B, ni hépatite C, à ce moment, il faut arrêter le suivi médical de l'accident d'exposition au sang.

Dans le cas où le prélèvement initial montre une infection à VIH ou une hépatite C ou une hépatite B chez le patient source, ou que le statut du patient source reste inconnu, il faut, à ce moment, évaluer le statut de la personne victime par rapport à l'infection à VIH par rapport à l'hépatite C et par rapport à l'hépatite B. Il faut demander chez la personne victime un prélèvement initial qui doit comprendre la recherche d'anticorps anti-VIH, la recherche d'anticorps anti-VHC, le dosage des transaminases, la recherche d'antigènes HPS, si pas de notion de vaccination contre l'hépatite B. Si la personne victime est vaccinée contre l'hépatite B, il faut demander le titrage d'anticorps anti-HPS. Il faut savoir que toute personne exposée doit 24 sur 24 avoir accès à une information homogène et écrite, à des démarches rapides, à l'avis d'un médecin référent pour décider d'une prophylaxie éventuelle. Dans le cadre du suivi, après l'accident d'exposition au son et concernant la prise en charge après exposition au virus de l'hépatite B, si le patient source un antigène HPS positif ou que le statut par rapport à l'hépatite B est inconnu, si la personne victime est vaccinée et répandeur, c'est-à-dire qu'elle a un titrage d'anticorps anti-HPS supérieur à 10 unités par litre, même ancien, il n'y a ni prophylaxie ni suivi à faire.

Si la personne victime n'est pas vaccinée ou s'il est vacciné, qu'il a reçu trois injections mais non répandeur, c'est l'indication des immunoglobulines spécifiques dans les 72 heures plus une vaccination dans les 72 heures jusqu'à 7 jours suivant l'accident d'exposition au son, la première injection puis la deuxième injection à un mois et la troisième à six mois après la première. Il faut instaurer un suivi par le dosage des alates et la demande de la sérologie de l'hépatite B, le jour

de l'accident d'exposition au son pour évaluation du statut de la personne victime, la demande d'une sérologie à trois mois et à six mois. Si la personne victime est vaccinée mais réponse inconnue, on en considère comme non répandeur et c'est l'indication des immunoglobulines plus la vaccination avec un contrôle des transaminases et de la sérologie de l'hépatite B. Pour la prise en charge médicale et le suivi post-exposition à l'hépatite C, si le patient source est infecté par le virus de l'hépatite C ou si son statut est inconnu, en l'absence d'immunoglobulines spécifiques et d'un vaccin anti-hépatite C, le suivi va reposer sur la surveillance chez la personne victime et son traitement en cas de séro-conversion.

Cette surveillance se fera à l'aide du dosage des transaminases, essentiellement les alates, le jour de l'accident d'exposition au son, un mois après et trois mois après. Cette surveillance va se baser aussi sur le dosage des anticorps anti-VHC, demandé au moment de l'accident d'exposition au son et contrôlé un mois et trois mois après. La PCR de l'hépatite C. Cette PCR qu'on peut demander chez le soignant devant un dosage des alates qui augmente ou systématiquement à un mois.

Si positive à son de la PCR, il faut traiter d'emblée cette hépatite C aiguë. Pour la prophylaxie post-exposition au VIH, il faut initier la prévention post-exposition le plus rapidement possible, idéalement dans les 4 heures qui suivent l'accident d'exposition au son et au plus tard dans les 72 heures suivant l'exposition. La durée de la prophylaxie est de 28 jours et il ne faut pas oublier de proposer un test de grossesse.

Voici un tableau qui résume les indications de la prophylaxie post-exposition au VIH en fonction du risque et de la nature d'exposition et en fonction du statut de la personne source. Si le patient est VIH positif, la prophylaxie post-exposition est recommandée si le risque est important ou intermédiaire. Si la sérologie est inconnue, la prophylaxie post-exposition est recommandée si le risque est important.

Il n'est pas recommandé si le risque est intermédiaire sauf si facteur de risque, c'est-à-dire si la personne appartient au groupe à risque, les partenaires sexuels multiples, des usagers de drogues injectables, des homosexuels ou des prisonniers. La prophylaxie post-exposition, il n'est pas recommandé quel que soit le statut de la personne source si le risque est estimé minime. Après l'évaluation du risque, la prophylaxie se fait par l'association des antirétroviraux, le ténofovir plus l'imtricitabine qui sont deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse plus l'opinavir, ritonavir, inhibiteur de protéase.

Le ténofovir a la posologie de 300 mg par jour en une prise par jour, l'imtricitabine a la posologie de 200 mg par jour en une prise et l'opinavir plus ritonavir a raison de 4 comprimés par jour en deux prises, espacées de 12 heures. Après l'exposition au VIH, il faut instaurer un suivi sérologique. Si indication de traitement prophylactique post-exposition, en plus de la sérologie VIH demandée le jour de l'accident, pour évaluer le statut de la personne victime par rapport à l'infection à VIH, il faut demander une sérologie VIH deux mois après l'accident et quatre mois

après l'accident d'exposition au sang.

Si pas de traitement prophylactique donné, il faut, en plus de la sérologie demandée le jour de l'accident, demander une autre sérologie VIH à la sixième semaine et au troisième mois après l'accident d'exposition au sang. Des conseils aux soignants, expliquer le risque de transmission, des attitudes à adopter pour éviter la transmission pendant toute la période du suivi, l'abstinence sexuelle ou l'utilisation du préservatif, ne pas donner de sang, de sperme ou d'organe, ne pas partager ni brosse à dents, ni rasoir, ni seringue et éviter la grossesse et l'allaitement. Informer sur les antirétroviraux, essentiellement sur les effets indésirables possibles.

En cas de survenue d'effets indésirables, il ne faut pas arrêter le traitement prophylactique post-exposition, il faut consulter en urgence le médecin référent dont la prise en charge des accidents d'exposition au sang en cas de survenue de ces effets indésirables. Toujours dans le cadre du suivi médical après l'accident d'exposition au sang, il faut toujours analyser les circonstances de la survenue de l'accident d'exposition au sang pour éviter la survenue d'un autre accident d'exposition au sang. Il faut déclarer l'accident de travail, il faut remplir la fiche de déclaration, insistant sur le respect des précautions universelles pour éviter la transmission virale du personnel soignant, ne jamais plier ou recapuchonner les aiguilles, ne pas dégager les aiguilles de seringues ou des systèmes de prélèvement sous vide à la main, jeter immédiatement les aiguilles et autres objets piquants ou coupants dans un conteneur adapté et imperforable, porter des gants pour tout risque de contact avec du sang, un liquide biologique contaminant, une lésion cutanée, des miqueuses ou du matériel souillé, porter des gants systématiquement si l'on est soi-même porteur de lésions cutanées ou de plaies cutanées, protéger toutes plaies, se laver les mains après le retrait des gants entre deux patients et deux activités, porter un masque, des lunettes, une surblouse lorsqu'il y a un risque de projection, décontaminer immédiatement les instruments utilisés et les surfaces souillées par du sang ou un autre liquide biologique avec de l'eau de Javel, fraîchement diluée à 10%, et se vacciner contre l'hépatite B et vérifier la réponse au vaccin.